

观察性队列稿件同行评审报告

公开演示情景：审查对象为虚构稿件片段，不对应真实作者、机构或未公开研究

一、审查依据与范围

本报告审查一份用于演示的观察性队列稿件，材料包括摘要、方法、结果正文、表 1 和图 1。稿件描述家庭血压监测频率与 12 个月收缩压变化的关联，但未提供研究方案、注册记录、原始数据、分析代码或补充材料。报告依据稿件内可见信息核对研究问题、时间零点、样本流、变量定义、统计方法、结果与论断；STROBE 仅用于识别报告缺项，不作为研究质量评分。由于未取得原始数据和代码，本报告不能声称数字真实、分析已复现或数据中不存在错误。

二、总体评价

稿件的问题具有明确的公共卫生意义，暴露、主要结局和随访时长在摘要中可以识别，表 1 也报告了主要组间估计和 95% 置信区间。当前最重要的问题不是语言风格，而是方法中没有清楚定义时间零点和暴露判定窗口，缺失数据处理无法与样本流对应，摘要结论又把观察性关联写成家庭监测改善血压控制的因果效果。这些问题会影响偏倚判断和主要结论的可解释性；作者需要先补充报告、核对分析对象并降低论断强度，之后才能评价现有估计是否足以支持稿件主张。

三、主要意见

M1 时间零点与暴露判定窗口未定义

类型为 reporting gap。位置为方法“研究对象与暴露”第一段。稿件写明按家庭测量频率分组，却未说明从哪一天开始累计测量、暴露窗口是否先于结局随访，也未说明在暴露窗口内发生药物调整或失访时如何处理。读者因此无法判断暴露与结局的时间顺序，也无法排除将必须存活并完成测量的时间错误归入暴露组。请给出统一时间零点、暴露判定窗口、纳入资格和随访起点，并用样本流说明每一步人数；若暴露随时间更新，应说明相应的时间变化分析。核验状态为需作者澄清。

M2 缺失数据与模型样本量不能对应

类型为 inconsistency。位置为结果第二段和表 1。正文称主要模型纳入全部 842 名研究对象，表 1 的结局可用人数合计为 801 名，方法只写“缺失值予以排除”，未说明缺失发生在哪些变量、排除顺序或模型实际分母。该差异可能改变估计精度并影响缺失偏倚判断。请按原始、符合资格、暴露可判定、结局可用和主要模型分析依次报告人数，同时说明各变量缺失量、完全病例或插补方法及其假设；若不同模型使用不同样本，应逐项报告分析人数。核验状态为稿件内已定位、未取得原始数据。

M3 摘要结论超过观察性证据

类型为 interpretation。位置为摘要结论和讨论末段。稿件使用“家庭监测可改善血压控制并应推广”的确定性措辞，但设计为非随机观察性队列，现有材料没有说明足以识别因果效应的策略，也没有报告绝对差异、伤害、成本或实施可行性。请将主要结论改为家庭监测频率与收缩压变化之间的调整后关联，明确残余混杂和选择偏倚，并把推广建议限定为需要进一步因果评价的研究问题。若作者坚持因果主张，需要说明 estimand、识别假设、混杂控制依据和相应敏感性分析。核验状态为稿件内已核对。

四、次要意见

- 1. m1 表 1：请在表题或表注中定义调整模型、参照组、分析人数和 95% 置信区间，保持所有单元格白底并使用三线表。
- 2. m2 统计符号：英文与数字使用 Times New Roman；P 使用粗斜体，其余拉丁统计符号如 t、F、z 使用斜体，HR、CI 和数值保持正体。
- 3. m3 图 1：图内只保留坐标、单位、图例和必要数值，不重复摘要结论或添加教材式解释；完整方法和限制放入正文或图注。

五、覆盖矩阵

维度	当前判断	问题编号	未核验边界
研究问题与贡献	问题可识别	M3	未核验外部创新性
数据与稿内一致性	存在分母冲突	M2	无原始数据
研究设计与偏倚	时间顺序不清	M1	无方案与注册
统计方法与不确定性	目前无法完整判断	M1、M2	无代码与诊断
结果、讨论与结论	论断强度过高	M3	未复算结果
语言、结构与表图	需局部规范化	m1~m3	仅审所给材料

六、未核验事项

本报告未核验作者身份、研究机构、伦理批准、原始数据、分析代码、参考文献真实性、期刊最新表单或稿件外的研究实施过程。报告没有给出录用、修改或拒稿建议，因为演示情景未提供目标期刊的决定类别和评价标准。若后续取得方案、数据或代码，应分别核对预设终点、样本流、主要模型、缺失处理和表图数字；只有实际运行授权代码后，才可把相应项目标记为已复算。